



Deutscher Bundestag

Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren,
Frauen und Jugend

Wortprotokoll der 7. Sitzung

Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Berlin, den 6. Oktober 2025, 14:00 Uhr
Paul-Löbe-Haus
2.200

Vorsitz: Saskia Esken, MdB

Tagesordnung - Öffentliche Anhörung

Einzigiger Tagesordnungspunkt

Seite 6

Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistentenausbildung

BT-Drucksache 21/1493

Federführend:

Ausschuss für Bildung, Familie, Senioren, Frauen
und Jugend

Mitberatend:

Ausschuss für Arbeit und Soziales
Ausschuss für Gesundheit
Haushaltsausschuss (mb und § 96 GO)

Berichterstatter/in:

Abg. Astrid Timmermann-Fechter [CDU/CSU]
Abg. N. N. [AfD]
Abg. Sabine Dittmar [SPD]
Abg. Simone Fischer [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]
Abg. Julia-Christina Stange [Die Linke]



Mitglieder des Ausschusses

Fraktion	Ordentliche Mitglieder	Anwesenheit	Stellvertretende Mitglieder	Anwesenheit
CDU/CSU	Albani, Stephan	nein	Bilic, Florian	ja
	Dahler, Wolfgang	ja	Borchardt, Simone	ja
	Demuth, Ellen	nein	Brodesser, Dr. Carsten	nein
	Edelhäuser, Ralph	nein	Düber, Dr. Hülya	nein
	Heveling, Ansgar	nein	Ehm, Lars Andre	nein
	Hose, Michael	nein	Grasse, Adrian	nein
	König, Anne	nein	Koob, Markus	nein
	Körner, Dr. Konrad	nein	Nacke, Dr. Stefan	nein
	Orthey, Harald	ja	Rohwer, Lars	nein
	Pöpsel, Oliver	ja	Schreiner, Felix	nein
	Schulz, Marvin	ja	Staffler, Katrin	nein
	Timmermann-Fechter, Astrid	ja	Willsch, Klaus-Peter	nein
	Weisgerber, Dr. Anja	nein	Zeulner, Emmi	nein
AfD	Bessin, Birgit	nein	Ebenberger, Tobias	nein
	Bollmann, Gereon	ja	Feser, Jan	nein
	Frömming, Dr. Götz	nein	Höchst, Nicole	nein
	Maack, Sebastian	ja	Kempf, Martina Rose-Marie	nein
	Przygodda, Kerstin	nein	Martel, Johann	nein
	Rathert, Dr. Anna	nein	Rehm, Lukas	nein
	Reichardt, Martin	ja	Storch, Beatrix von	nein
	Rudzka, Angela	nein	Strauß, Otto	nein
	Zaum, Christian	nein	Weiss, Claudia	ja
SPD	Dittmar, Sabine	ja	Baldy, Daniel	nein
	Döring, Felix	nein	Kaczmarek, Oliver	nein
	Esken, Saskia	ja	Rump, Daniela	nein
	Hostert, Jasmina	ja	Schmidt, Dagmar	nein
	Ortleb, Josephine	nein	Seitzl, Dr. Lina	nein
	Rabanus, Martin	nein	Wagner, Dr. Carolin	nein
	Reichardt, Truels	ja	N. N.	
BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN	Khan, Misbah	nein	Fischer, Simone	ja
	Loop, Denise	nein	Lehmann, Sven	nein
	Reinalter, Dr. Anja	ja	Rüffer, Corinna	nein
	Schauws, Ulle	nein	Vriesema, Mayra	nein
	Slawik, Nyke	ja	Winklmann, Tina	nein



Fraktion	Ordentliche Mitglieder	Anwesenheit	Stellvertretende Mitglieder	Anwesenheit
Die Linke	Eißing, Mandy Gebel, Kathrin Gohlke, Nicole Kaminski, Maren	nein nein nein ja	Brückner, Maik Hermeier, Mareike Reichinnek, Heidi Stange, Julia-Christina	nein nein nein ja

Mitglieder der Bundesregierung

- Michael Brand, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Mitglieder der mitberatenden Ausschüsse

- Axel Müller (CDU/CSU), Ausschuss für Gesundheit
- Anne Janssen (CDU/CSU), Ausschuss für Gesundheit
- Claudia Moll (SPD), Ausschuss für Gesundheit
- Svenja Stadler (SPD), Haushaltsausschuss.



Anwesenheitsliste der sachverständigen Gäste

zur 7. Sitzung des Ausschusses für Bildung, Familie, Senioren, Frauen
und Jugend am 6. Oktober 2025, ab 14.00 Uhr

Stand: 6. Oktober 2025

	Anwesenheit
Kathrina Edenharter³ Deutscher Pflegerat e. V. (DPR)	ja
Dr. Elisabeth Fix² Deutscher Caritasverband e. V.	kurzfristig erkrankt
Christian Hener¹ Deutsches Rotes Kreuz e. V. (DRK)	ja
Isabel Kalberlah² Hans-Weinberger-Akademie der AWO e. V.	ja
Katharina Owczarek¹ Diakonie Deutschland Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V.	ja
Anna Traub¹ Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.	ja
Antonia Walch¹ Bundesverband Deutscher Privatkliniken e. V. (BDPK)	ja
Melanie Wehrheim⁴ Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di	ja



¹ Auf Vorschlag der Fraktion der CDU/CSU zur öffentlichen Anhörung eingeladen.

² Auf Vorschlag der Fraktion der SPD zur öffentlichen Anhörung eingeladen.

³ Auf Vorschlag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zur öffentlichen Anhörung eingeladen.

⁴ Auf Vorschlag der Fraktion Die Linke zur öffentlichen Anhörung eingeladen.

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände

	Anwesenheit
Deutscher Landkreistag Dominik Feldmeier	ja



Die **Vorsitzende:** Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Ausschussmitglieder, liebe Gäste, ich begrüße Sie zu unserer heutigen 7. Sitzung.

Vom Bildungs- und Familienministerium heiße ich Herrn Parlamentarischen Staatssekretär Michael Brand sehr herzlich willkommen.

Ich begrüße auch die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie die übrigen Kolleginnen und Kollegen, die uns nach Benennung eines Grundes heute per Videokonferenz bzw. Telefon zugeschaltet sind. Wie üblich, rufe ich Sie jetzt auf, damit wir auch die Anwesenheit geklärt haben und auch keine weiteren Anwesenden haben.

Hinweis des Sekretariats: Folgende Abgeordnete haben sich per Zoom zur Sitzung zugeschaltet:

- Oliver Pöpsel (CDU/CSU)
- Gereon Bollmann (AfD)
- Svenja Stadler (SPD),
- Truels Reichardt (SPD).

Vielen Dank.

Dann teile ich Ihnen im Namen der Fraktion Die Linke mit, dass Frau Cansin Köktürk, MdB, für die Dauer dieser Sitzung auf ihren Sitz als stellvertretendes Mitglied verzichtet. Frau Julia-Christina Stange, MdB, wurde an ihrer Stelle als stellvertretendes Mitglied benannt. Nach der Sitzung wird der ursprüngliche Zustand der Mitgliedschaften wiederhergestellt.

Wir führen heute die öffentliche Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung „Entwurf eines Gesetzes über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistentenausbildung“ auf BT-Drucksache 21/1493 durch.

Zu dieser Anhörung liegen Ihnen die Formulierungshilfen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD sowie die Änderungsanträge der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN verteilt als Ausschussdrucksache 21(13)11 vor, die ebenfalls

Gegenstand der Anhörung werden. Weiterhin liegen Ihnen die Stellungnahme des Bundesrates und die Gegenäußerung der Bundesregierung auf BT-Drucksache 21/1940 vor.

Ich begrüße jetzt nochmal ausführlich die Mitglieder des Bildungs- und Familienausschusses, die Mitglieder der mitberatenden Ausschüsse, die Zuschauerinnen und Zuschauer und natürlich die Sachverständigen für unsere heutige Anhörung.

Das sind:

- Kathrina Edenharter, Präsidiumsmitglied, Deutscher Pflegerat e. V. (DPR)
- Christian Hener, Referent für Pflegeberufe und Kompetenzentwicklung in der Pflege, Deutsches Rotes Kreuz e. V. (DRK)
- Isabel Kalberlah, Leitung Referat Schulen, Hans-Weinberger-Akademie der AWO e. V.
- Katharina Owczarek, Diakonie Deutschland, Zentrum für Gesundheit, Rehabilitation und Pflege, Referentin für stationäre und teilstationäre Altenhilfe und Pflege
- Anna Traub, Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V., Wissenschaftliche Referentin Arbeitsfeld II – Kindheit, Jugend, Familie, Soziale Berufe
- Antonia Walch, stellvertretende Geschäftsführerin, Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V. (BDPK)
- Melanie Wehrheim, Bereichsleiterin Berufspolitik/Jugend, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di, Fachbereich Gesundheit, Soziale Dienste, Bildung und Wissenschaft

und von den Kommunalen Spitzenverbänden



- Dominik Feldmeier, Referent, Deutscher Landkreistag.

Frau Dr. Elisabeth Fix, Leiterin der Kontaktstelle Politik beim Deutschen Caritasverband e. V., musste ihre Teilnahme leider absagen, da sie erkrankt ist. Sie hat aber ihr Eingangsstatement übersandt, das Sie als Ausschussdrucksache 21(13)12 ebenfalls vorliegen haben.

Zu unserer Anhörung liegen angeforderte Stellungnahmen der Sachverständigen als Ausschussdrucksachen 21(13)9a-neu bis 9i sowie unangeforderte Stellungnahmen als Ausschussdrucksachen 21(13)10a bis 10h vor. Diese sind per E-Mail an alle verteilt worden.

Ich weise Sie darauf hin, dass die Anhörung live übertragen und im Internet abrufbar sein wird.

Von dieser Anhörung wird ein Wortprotokoll erstellt, das auch auf der Homepage des Bildungs- und Familienausschusses abrufbar sein wird. Dort finden Sie auch die schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen.

Bild- und Tonaufzeichnungen durch andere Personen als durch unsere Technik sind während der Sitzung nicht gestattet. Anderes gilt für akkreditierte Vertreterinnen und Vertreter der Medien. Deshalb bitte ich darum, während der Anhörung auf die Benutzung von Mobiltelefonen möglichst zu verzichten.

Der Ablauf der öffentlichen Anhörung gestaltet sich wie folgt: Die Sachverständigen geben Eingangsstatements in der Länge von etwa drei Minuten ab. Danach folgt eine Frage- und Antwortrunde von 60 Minuten.

Bei dieser Frage- und Antwortrunde wird das Fragerecht nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen zeitlich aufgeteilt. Die jeweiligen Zeitkontingente gelten für Fragen und Antworten. Achten Sie hier also bei der Formulierung Ihrer Frage darauf, dass Sie den gefragten Personen Zeit geben, zu antworten.

Die zeitliche Aufteilung der Fraktionen gestaltet sich nach unserem Organisationsstatut wie folgt:

- CDU/CSU: zehn Minuten
- AfD: sieben Minuten
- SPD: sechs Minuten
- BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: acht Minuten
- Die Linke: sechs Minuten
- CDU/CSU: zehn Minuten
- AfD: sieben Minuten
- SPD: sechs Minuten.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn jede Fragestellerin bzw. jeder Fragesteller in einem Beitrag maximal zwei Fragen an einen oder zwei Sachverständige richten und auch explizit sagen würde, an wen sich die Frage richtet.

Ein Hinweis noch zum Zeitmanagement: Die jeweils zur Verfügung stehende Zeit wird Ihnen über den Monitor im Saal sowie in der Videokonferenz angezeigt. Ich bitte die Fragenstellenden sowie die Sachverständigen, diese Uhr jeweils im Blick zu behalten.

Wir beginnen jetzt mit der öffentlichen Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung „Entwurf eines Gesetzes über die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistentenausbildung“ auf BT-Drucksachen 21/1493 und 21/1940.

Zunächst bitte ich die Sachverständigen um ein kurzes Eingangsstatement von jeweils drei Minuten.

Frau Edenharter macht den Anfang und dann gehen wir in alphabetischer Reihenfolge durch. Den Abschluss bildet der Vertreter der Kommunalen Spitzenverbände, Herr Feldmeier.

Frau Edenharter, Sie haben das Wort.

Kathrina Edenharter (Deutscher Pflegerat e. V.): Sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Gelegenheit, zum Gesetzentwurf sprechen zu dürfen.



Der Deutsche Pflegerat begrüßt ausdrücklich das Ziel, mit einer einheitlichen Pflegefachassistenten-ausbildung klare Verhältnisse zu schaffen. So lassen sich Qualität und Sicherheit in der Versorgung gewährleisten und es ist ein guter Einstieg in den Pflegeberuf. Die bisher in den Ländern unterschiedlich geregelte Ausbildung steht einem modernen Pflegebildungssystem im Weg. Sie verhindert die Durchlässigkeit, hemmt die Entwicklung eines guten Qualifikationsmixes und behindert die Mobilität. Das führt zu unterschiedlichen Bedingungen in der Praxis und zu Unterschieden in der Versorgung.

Drei Punkte sind uns besonders wichtig: Erstens, die Ausbildungsdauer und das Kompetenzniveau. Eine zweijährige Ausbildung auf DQR-Niveau 3 sichert die notwendige Kompetenz und ermöglicht auch eine Übertragung zur Pflegefachperson. Eine Verkürzung auf die im Entwurf vorgesehenen 18 Monate oder sogar 12 Monate würde dieses Kompetenzprofil deutlich absenken. Eine zwölfmonatige Ausbildung wäre faktisch eine Ausbildung zur Hilfskraft mit stark eingeschränkten Einsatzmöglichkeiten und spürbaren Qualitätseinbußen. Das steht den steigenden Anforderungen an die Pflege entgegen und kann nicht das Ziel derjenigen sein, die eine einjährige Ausbildung vorschlagen. Auch mit einer Ausbildungsdauer von 18 Monaten können die entsprechenden Kompetenzen, die das Ausbildungsziel der Pflegefachassistenten-ausbildung aktuell vorsieht, kaum vermittelt werden. Unsere Pflege ist zudem auf die Mitarbeitenden aus dem Ausland angewiesen. Bei weniger als 24 Monaten Ausbildung erhalten diese keine Ausbildungsduldung oder Aufenthaltserlaubnis. Zudem würde die Förderung durch die Bundesagentur entfallen. Angesichts des hohen Bedarfs an Pflegefachassistentenpersonen können wir uns das nicht leisten.

Zweitens, Professionalität und klare Rollen: Pflege ist ein verantwortungsvoller und sinnstiftender Beruf. Damit die Ausbildung wirkt, braucht es eine klare Abgrenzung der Kompetenzen und Aufgaben zwischen Pflegefachpersonen mit und ohne akademische Qualifizierung sowie Pflegefachassistentinnen und Pflegefachassistenten. Ausbildungsgänge müssen gut aufeinander abgestimmt sein und in einem Qualifikationsmix

zusammenwirken. So steigt die Attraktivität des Berufes und die Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten. Hier setzt das Projekt „BAPID - Bildungsarchitektur der Pflege in Deutschland“ des Deutschen Pflegerats an. Es zeigt, wie klare Rollenbilder definiert und Bildungswege miteinander verbunden werden können. Die Pflegefachassistenten-ausbildung sollte deshalb eng mit BAPID verknüpft werden.

Drittens, die Einheitlichkeit. Die heutige Vielfalt von 27 verschiedenen Landesregelungen wird mit dem Gesetz beendet. Das ist ein wichtiger Schritt. Wir brauchen bundeseinheitliche Standards, um Qualität, Vergleichbarkeit, Mobilität und Rechtssicherheit zu schaffen.

Und zum Schluss: Der Deutsche Pflegerat fordert eine bundeseinheitliche zweijährige Ausbildung. Sie ist die Voraussetzung für Kompetenz, Versorgungssicherheit und gute Bildungswege. Das stärkt die Profession der Pflege und sendet ein klares Signal für die Attraktivität des Berufes. Vielen Dank.

Die **Vorsitzende**: Vielen Dank, Frau Edenharter. Dann machen wir weiter mit Herrn Hener. Bitte schön.

Christian Hener (Deutsches Rotes Kreuz e. V.): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Christian Hener. Ich bin Referent für Pflegeberufe beim Deutschen Roten Kreuz. Ich erkläre, keine Interessenkonflikte jenseits meiner Stellenbeschreibung zu haben.

Insgesamt begrüßen wir die Einführung einer bundesweit einheitlich gestalteten Ausbildung zur Pflegefachassistenten mit 18-monatiger Dauer sehr. Die Rolle der Pflegefachassistenten könnte den Skill- und Grade-Mix in der professionellen Pflege effektiv bereichern und gleichzeitig für neue Zielgruppen Zugänge in das Pflegebildungssystem eröffnen. Insofern trägt die Pflegefachassistenten-ausbildung nicht nur zu mehr Versorgungssicherheit bei, sondern sie führt auch zu mehr Bildungschancen und Aufstiegsmöglichkeiten. Trotz eines hohen Bedarfs an qualifiziertem Personal



unterhalb der Pflegefachausbildung sprechen wir uns für die 18-monatige Dauer aus, gerade auch mit Blick auf das Berufsprofil, das deutlich über die reine Pflegehilfe hinausgeht und als Heilberuf geregelt werden soll. Aus unserer Sicht kommt damit eine einjährige Ausbildung nicht infrage. Gleichzeitig halten wir aber auch die Ausbildungsdauer von 24 Monaten für zu lange, um den dringend benötigten Personalkörper in der Pflegefachassistenz effektiv, aber auch effizient, aufbauen zu können.

Obwohl im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens bereits einige wichtige Anpassungen zur Umsetzung erfolgten, möchten wir noch kurz stichpunktartig auf folgende Änderungserfordernisse hinweisen, die wir in unserer Stellungnahme näher ausführen und auf die gegebenenfalls später in der Fragerunde noch zurückgekommen werden kann. Wir wissen, dass einige dieser Punkte die Landesebene betreffen. Trotzdem möchten wir sie hier der Vollständigkeit halber ausführen.

Einmal wünschen wir uns, dass die Finanzierung der Ausbildungskosten, die den Pflegebedürftigen in Rechnung gestellt werden, aus Mitteln des Ausgleichsfonds der sozialen Pflegeversicherung finanziert werden.

Wir wünschen uns eine Flexibilisierung der 10%-Praxisanleitung, insbesondere für die ambulante Pflege. Hier liegt das größte Wachstumspotenzial in der Ausbildung für die Pflegefachausbildung, aber auch für die Pflegefachassistenz. Gerade für kleine ambulante Pflegedienste ist es schwierig, die 10%-Praxisanleitung zu realisieren.

Außerdem wünschen wir uns eine Dynamisierung der Mindestanforderungen für die Pflegeschulen, Stichwort Master-Niveau in der Lehre, die sich sozusagen an den realen Gegebenheiten des Arbeitsmarktes lokal orientiert.

Wir wünschen uns, dass mehr Quereinstiege in die Berufspädagogik erfolgen können, weil gerade der Mangel an Lehrenden in der Pflegeausbildung, sei es in der Pflegefachausbildung oder in der Pflegefachassistentenausbildung, so ist, dass auch von

einem großen Fachkräftemangel, der auch schon fast Dimensionen wie in der praktischen Pflege annimmt, zu sprechen ist. Hier brauchen wir dringend Lösungen, damit wir die Ausbildung skalieren können.

Außerdem, und das ist uns besonders wichtig, wünschen wir uns eine systematische Finanzierung für die Schulsozialarbeit an den Pflegeschulen. Gerade für die Pflegefachassistentenausbildung haben wir bei den bisherigen einjährigen Ausbildungen nach Landesrecht die Erfahrung gemacht, dass diese Klientel doch Herausforderungen mit sich bringt, die der Schulsozialarbeit bedürfen. Wir haben auch sehr gute Erfahrungen mit Pflegeschulen, die die Schulsozialarbeit umgesetzt haben. Damit mache ich erst einmal einen Punkt.

Die **Vorsitzende**: Vielen Dank, Herr Hener. Dann machen wir weiter mit Frau Kalberlah.

Isabel Kalberlah (Hans-Weinberger-Akademie der AWO e. V.): Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, es ist kein Geheimnis, die Pflege in Deutschland steht an einem entscheidenden Wendepunkt. Weniger Pflegekräfte stehen einer wachsenden Zahl von Menschen gegenüber, die auf Unterstützung und professionelle Versorgung angewiesen sind. Diese Entwicklung zeigt deutlich, wir brauchen gut ausgebildete Pflegekräfte auf allen Qualifikationsniveaus. Denn ohne sie wird eine verlässliche Versorgung künftig nicht mehr möglich sein. Mit dem Pflegefachassistentengesetz erfolgt ein wichtiger Schritt zur Sicherstellung der pflegerischen Versorgung. Es ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einer bundesweit einheitlichen Regelung pflegerischer Berufe.

Auch wenn vielleicht aus pädagogisch-didaktischer Sicht eine längere Ausbildungsdauer wünschenswert wäre, sprechen wir uns klar für die bundeseinheitliche 18-monatige Ausbildung aus. Entscheidend dabei ist jedoch, dass die Lernenden durch gezielte Sprachförderung und schulsozialarbeiterische Begleitung wirksam unterstützt werden, um Ausbildungsabbrüche zu vermeiden, was sich auch in den Pauschalen widerspiegeln muss.



Erlauben Sie mir noch einen weiteren, jedoch wichtigen Punkt zum Thema Finanzierung: Die Sicherstellung der Ausbildungsfinanzierung durch die Anbindung an den Ausbildungsfonds ist ein richtiger und wichtiger Schritt. Gleichzeitig führt die Beibehaltung der bisherigen Finanzierungslogik zu weiter steigenden Kosten für pflegebedürftige Menschen, und das darf nicht sein. Die Ausbildungskosten müssen als gesamtgesellschaftliche Aufgabe gelten und sind aus den Eigenanteilen der Pflegebedürftigen herauszunehmen, bestenfalls vollständig aus Steuermitteln zu finanzieren.

Damit die Ausbildung nicht nur finanziell, sondern auch strukturell tragfähig ist, müssen ihre Rahmenbedingungen realistisch gestaltet werden. Eine 18-monatige Dauer der Ausbildung korreliert keineswegs mit den typischen Schulzyklen eines normalen Schuljahres. Denn je nach aktuell geltender landesrechtlicher Regelung zu den möglichen Start- und Endzeiten der Ausbildung würde mindestens ein Monat Leerlauf entstehen, für die Pflegeschule in Bezug auf die Personalplanung und für die Absolventinnen und Absolventen als Wartezeit. Pflegeschulen sollten daher die Möglichkeit erhalten, innerhalb definierter Korridore Start- und Endpunkte eigenverantwortlich zu planen, um Leerlaufzeiten und ungenutzte Kapazitäten zu vermeiden. Nicht nur dadurch entstehen den Schulen erhebliche Herausforderungen für die Personalbedarfsplanung. Die Mindestanforderungen an Lehrkräfte sind mit den vorhandenen Ressourcen kaum zu erfüllen. Es braucht mehr Studienplätze für Pflegepädagogik und Medizinpädagogik und flexible Lösungen, um den dringend nötigen Qualifikationszuwachs tatsächlich abzudecken.

Sehr geehrte Damen und Herren, das Pflegefachassistenzgesetz ist ein zentraler Baustein für die Zukunft der Pflege. Entscheidend ist nun, dass es praxistauglich umgesetzt wird, für die Auszubildenden, für die Träger der praktischen Ausbildung, für die Pflegeschulen und für die Pflegebedürftigen. Vielen Dank.

Die **Vorsitzende**: Herzlichen Dank. Dann machen wir weiter mit Frau Owczarek.

Katharina Owczarek (Diakonie Deutschland, Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V.): Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, die Diakonie begrüßt die Einführung der bundeseinheitlichen Pflegefachassistentenausbildung ausdrücklich als entscheidenden Schritt zur Stärkung der Pflegeberufe und zur Schaffung eines einheitlichen generalistischen Berufsbildes. Für eine hochwertige pflegerische Versorgung braucht es in Zukunft eines ausgewogenen Qualifikationsmixes von Pflegeassistenten, Pflegehilfskräften und beruflich akademisch ausgebildeten Pflegekräften. Dieser Qualifikationsmix ist notwendig, um bedarfsgerechte Qualität, Effizienz und bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege zu schaffen.

Damit die Pflegefachassistentenausbildung allerdings einen echten Beitrag zur Pflegekraftsicherung und zu einer nachhaltigen Verbesserung der Pflegebedingungen in Deutschland leisten kann, braucht es aus Sicht der Diakonie noch folgende Anpassungen:

Der im Gesetzesentwurf angelegte Kompetenzerwerb ermöglicht Pflegefachassistentenkräften künftig mehr eigenverantwortliches Handeln, entlastet damit die Pflegefachpersonen und steigert die Versorgungsqualität. Allerdings müssen die Ausbildungsziele klarer von den Vorbehaltsaufgaben der Pflegefachkräfte abgegrenzt werden.

Die geplante Finanzierung über den Ausbildungsfonds stellt einen bewährten und soliden Rahmen dar, der die Pflegefachassistenten attraktiver für Auszubildende, Träger und Pflegeschulen macht.

Den Zugang für Menschen ohne Berufsabschluss bewertet die Diakonie ausdrücklich positiv. Für die dazu vorgesehene Prognoseentscheidung der Pflegeschulen braucht es aber zwingend bundeseinheitliche Kriterien.

Für eine nachhaltige Absicherung der Ausbildungsplätze bedarf es zudem einer Weiterentwicklung der Finanzierungsstrukturen. Statt der monatlichen Pro-Kopf-Finanzierung brauchen vor allem Pflegeschulen eine stabile Kursfinanzierung,



die neben dem Ausfall vor allem auch die Vorhaltekosten abdeckt. Ebenso müssen besondere Fördermaßnahmen wie Schulsozialarbeit und gezielte Sprachförderung refinanziert werden, um Auszubildende mit herausfordernden Lebensbiografien optimal begleiten zu können. Die Beteiligung der Pflegebedürftigen an den Ausbildungskosten ist dringend abzuschaffen und durch eine solidarische Finanzierung aus Steuermitteln zu ersetzen, denn Ausbildung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe.

Nach dem neuen Personalbemessungsverfahren für die stationäre Pflege liegt der zukünftige Bedarf allein in diesem Sektor bei etwa 110.000 Pflegeassistentenkräften, ein Bedarf, der angesichts des demografischen Wandels in Deutschland auch durch internationale Arbeitskräfte gedeckt werden muss. Die Engführung auf Gewinnung von ausländischen Fachkräften muss daher aufgehoben werden, indem die Pflegefachassistentenausbildung einer qualifizierten Berufsausbildung im § 2 Absatz 12a Aufenthaltsgesetz gleichgestellt wird. Vielen Dank.

Die **Vorsitzende**: Ganz herzlichen Dank. Dann kommen wir zu Frau Traub.

Anna Traub (Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.): Der heute zur Diskussion stehende Gesetzentwurf der Bundesregierung markiert auch aus Sicht des Deutschen Vereins einen kaum zu überschätzenden Schritt hin zu einem konsistenten wie ebenso durchlässigen Berufs- und Ausbildungssystem in der Pflege. Ein System, das Menschen mit unterschiedlicher Vorbildung und in unterschiedlichen Lebenssituationen zugänglich ist und für sie attraktiv sein kann.

Eine Befassung in den Gremien des Deutschen Vereins mit seiner heterogenen Mitgliederstruktur war zeitlich nicht möglich. Daher beschränkt sich die Geschäftsstelle des Deutschen Vereins in ihrer Stellungnahme auf die großen Linien des Entwurfs. Diese sind umfassend zu befürworten.

In der Entscheidung für eine 18-monatige Ausbildungsdauer sieht die Geschäftsstelle des

Deutschen Vereins einen sachgerechten Kompromiss im Spektrum der vorgebrachten Positionen, aber auch in der Abschätzung einerseits der notwendigen Vermittlung der erweiterten Kompetenzen, unter anderem mit Blick auf die Anwendung des Personalbemessungsinstruments in der stationären Langzeitpflege, und andererseits aber auch der Gewährleistung der Niedrigschwelligkeit des Berufszugangs.

Zu begrüßen sind in diesem Zusammenhang auch die Anrechnungs- und Anerkennungsregelungen der Paragraphen 11 und 25, die neben gleichwertigen Ausbildungen und Abschlüssen auch praktische berufliche oder durch lebenslanges Lernen erworbene Erfahrungen berücksichtigen.

Die Einführung der Ausbildungsvergütung, das erübrigt sich fast zu sagen, und ihre verlässliche Finanzierung sind sowieso absolut begrüßenswert, konsequent und wichtig, ebenso wie die Finanzierung der Kosten der praktischen Ausbildung.

Nun komme ich zu unserem Kritikpunkt, der ein bisschen ungerecht dieses Gesetz betrifft, weil es eigentlich nicht Ihre Baustelle ist: Die derzeitige Nutzung des Ausgleichsfonds, die die Kosten der Ausbildung insbesondere den Pflegebedürftigen, ihren Angehörigen oder aber im Fall der Sozialhilfebedürftigkeit den Kommunen aufbürdet, kritisiert auch der Deutsche Verein in diesem Zusammenhang vehement und fordert, dass die Bund-Länder-Kommission zur Pflegereform möglichst zeitnah Vorschläge zu einer alternativen Finanzierung – wie im Koalitionsvertrag vorgesehen – vorlegt und dass diese dann auch nicht versanden, sondern vom Gesetzgeber zeitnah und zügig umgesetzt werden.

Eine letzte Bemerkung: Um zum Jahresbeginn 2027 hin schon ein stabiles Ausbildungssystem zu gewährleisten, drängt zunehmend die Zeit. Auch deshalb begrüßt die Geschäftsstelle des Deutschen Vereins einen zügigen Abschluss des bereits in der letzten Legislaturperiode sehr weit gediehenen Gesetzgebungsverfahrens. Vielen Dank.



Die **Vorsitzende**: Danke, dann kommen wir zu Frau Walch.

Antonia Walch (Bundesverband Deutscher Privatkliniken e. V.): Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, der BDPK vertritt unter anderem 600 Reha-Einrichtungen in privater Trägerschaft. Ich möchte mich jetzt auch hier nur auf unsere Position beschränken, dass Reha-Einrichtungen Pflegefach- und Pflegefachassistentenkräfte ausbilden sollen dürfen.

Wir haben über 1.000 Reha-Einrichtungen in Deutschland, ambulant und stationär. Diese beschäftigen 21.000 Pflegevollzeitkräfte. Jede Reha-Einrichtung muss Pflegekräfte beschäftigen. Das sind Personalvorgaben der Rentenversicherung und der Krankenversicherung. Die Einrichtungen können also einen Großteil des Curriculums bei der Pflegeausbildung auch selber ausbilden, insbesondere in der Akutpflege und in der stationären Langzeitpflege. Sie bräuchten aber trotzdem auch Kooperationspartner, das ist aber bei den anderen Ausbildungsträgern nicht anders. Es ist aber gewährleistet, dass der überwiegende Anteil der Ausbildung in den Einrichtungen stattfinden kann. Viele Einrichtungen haben bereits Praxisanleiterinnen vor Ort. Derzeit müssen die Reha-Einrichtungen ihre Pflegekräfte von den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen rekrutieren, können also nicht selber ihre Pflegekräfte schon mit der Pflegeausbildung binden. Da würden jetzt auch diese 160 Stunden beim weiteren Einsatz, was ja auch nur ein Wahleinsatz ist, nichts ändern. Zudem sind 160 Stunden für die Einrichtungen einfach zu aufwendig, zumal sie ja meistens in ländlichen Gebieten liegen und man irgendwie sehen müsste, wie man diese Pflegeschüler für 160 Stunden zur Einrichtung, also mit Übernachtungsmöglichkeiten oder was auch immer, bringt.

Die Krankenhausreform wird zu einer Krankenhausstandortverdichtung führen, wo vielleicht dann auch Plätze auf dem Land, Ausbildungsplätze gerade in ländlichen Gebieten wegfallen können, da können die Reha-Einrichtungen insbesondere auch in diese Lücke springen.

Hinzu kommt, dass die Pflegefachassistentenausbildung derzeit auch Reha-Einrichtungen für ihre Praxiseinsätze miteinbezieht. Diese Plätze würden jetzt alle wegfallen, weil sie ja nicht mehr dürfen; und die Pflegeschulen suchen jetzt schon händelnd nach weiteren Plätzen.

Für die Finanzierung wären die Reha-Einrichtungen in jedem Fall bereit. Wir schätzen grob, dass etwa 2.000 Ausbildungsplätze hinzukommen könnten. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der Deutsche Pflegerat, der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe, der Berufsverband Lehrende Gesundheits- und Sozialberufe, die AOK und der Bundesrat sprechen sich dafür aus, dass die Reha-Einrichtungen Pflege ausbilden dürfen und trauen es den Einrichtungen damit auch zu. Aufgrund des hohen Pflegekräftemangels, der sich noch weiter vergrößern wird, denken wir, sollte man diese Chance nutzen. Danke.

Die **Vorsitzende**: Herzlichen Dank. Dann machen wir weiter mit Frau Wehrheim.

Melanie Wehrheim (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di): Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, für die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Stellung nehmen zu können.

Es ist richtig, den derzeitigen Flickenteppich landesrechtlicher Regelungen durch eine bundeseinheitliche Pflegeassistentenausbildung abzulösen. Damit diese gut gestaltet wird, sehen wir insbesondere drei Punkte, die nachzubessern oder zu stärken sind.

Der erste Punkt betrifft die Ausbildungsdauer. Hier sehen wir angesichts steigender Anforderungen in der pflegerischen Versorgung, dass es so viel Fachlichkeit wie möglich braucht. Eine Ausbildung von zwei Jahren ist aus unserer Sicht das Mindeste, auch damit die notwendigen Kompetenzen erworben werden können. Zu bedenken ist zudem, dass hier ein Heilberuf geschaffen werden soll. Kürzere als zweijährige Ausbildungen gibt es derzeit bei den Heilberufen nicht. Und auch nach



Berufsbildungsgesetz gibt es keine Ausbildung unter einer zweijährigen Dauer.

Zweitens: Wichtig ist uns, dass Pflegefachassistenten sich zu Fachkräften weiter qualifizieren können und dass das auch systematisch gefördert wird. Eine abgeschlossene Pflegefachassistentenausbildung ist daher im vollen Umfang auf die Dauer der Fachausbildung anzurechnen. Der Einstieg in die Fachausbildung muss auch nahtlos möglich sein. Wichtig ist uns auch, damit die Absolventen weitere berufliche Perspektiven haben, dass mit der Pflegefachassistentenausbildung die Möglichkeit besteht, einen allgemeinbildenden, also einen mittleren Schulabschluss erwerben zu können.

Drittens braucht es eine hohe Ausbildungsqualität. Notwendig ist aus unserer Sicht insbesondere eine Stärkung der Praxisanleitung. Wenn Auszubildende gut angeleitet werden, wissen wir aus der Praxis, fühlen sie sich sicherer und sind auch zufriedener mit ihrer Ausbildung. Das macht es wahrscheinlicher, dass sie nach dem Abschluss bleiben, beziehungsweise sich auch für die Fachausbildung entschließen. Insgesamt muss gewährleistet sein, dass mit den Ausbildungsvorgaben die Ausbildung im Vordergrund steht und die Auszubildenden unterstützt und individuell gefördert werden, um ihre Ausbildung erfolgreich abschließen zu können. Das gilt für die praktische und theoretische Ausbildung gleichermaßen. Hier ist unter anderem für die theoretische Ausbildung auch denkbar, begleitende Maßnahmen wie die Schulsozialarbeit oder die Sprachförderung zu stärken.

Eine bundeseinheitliche Ausbildung ist ein richtiger und wichtiger Schritt. Entscheidend ist, dass sie von der Versorgung her gedacht gut gestaltet wird und ein gutes Miteinander von unterschiedlich qualifizierten Pflegepersonen möglich ist. Danke schön.

Die **Vorsitzende**: Ganz herzlichen Dank, Frau Wehrheim. Dann haben wir noch Herrn Feldmeier. Bitte schön.

Dominik Feldmeier (Deutscher Landkreistag):

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, die Landkreise sind in vieler Hinsicht von diesem Regierungsentwurf betroffen. Insbesondere als Träger von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, als Träger von Pflegeschulen und auch berufsbildenden Schulen, sowie als Träger der Sozialhilfe und der Heimaufsicht.

Insbesondere vor dem Hintergrund des derzeitigen Fachkräftemangels in der Pflege und der Möglichkeit, die Attraktivität des Pflegeberufes steigern zu können, begrüßen wir die Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegefachassistentenausbildung.

Wir befürworten auch überwiegend die 18-monatige Ausbildungsdauer, damit den Auszubildenden Kompetenzen vermittelt werden können, um die Pflegefachkräfte auch wirklich entlasten zu können. Allerdings muss auch eine gute Durchlässigkeit in die generalistische Pflegeausbildung gewährleistet sein, da diese häufig nur zum vollen Ausbildungsjahr beginnt.

Den Hauptschulabschluss erachten wir als zielgruppengerecht. Insbesondere vor dem Hintergrund, die Attraktivität des Pflegeberufes steigern zu können, erachten wir einen zielgruppengerechten Zugang zu der Ausbildung auch als sachgemäß.

Wir kritisieren allerdings, dass derzeit noch wichtige Parameter fehlen, die in den noch ausstehenden Ausbildungs- und Prüfungsverordnungen definiert werden sollen. Demzufolge fehlen noch Angaben zu den angesetzten Stunden für den Unterricht und die praktische Ausbildung sowie für die verschiedenen Pflichteinsätze.

Angelehnt daran sehen wir auch etwas mit Skepsis, dass die vorgesehene Verteilung der praktischen Pflichteinsätze nach den Anforderungen der generalistischen Pflegeausbildung vorgesehen ist. Insbesondere in ländlichen Räumen bedarf es bereits größter Anstrengungen, die Pflichteinsätze in den ambulanten Diensten und den Krankenhäusern sicherzustellen.



Wir befürworten außerdem die Möglichkeit, über eine positive und sachliche Prognose auch Personen ohne einen Hauptschulabschluss den Zugang zur Ausbildung ermöglichen zu können. Allerdings fragt man sich diesbezüglich anhand welcher Kriterien eine solche Prognose erstellt werden kann beziehungsweise soll. Diese beiden genannten Punkte hat auch der Bundesrat in seiner Stellungnahme bereits thematisiert, was wir ebenfalls begrüßen. Danke.

Die **Vorsitzende**: Ganz herzlichen Dank, Herr Feldmeier. Herzlichen Dank an alle Sachverständigen.

Wir beginnen jetzt mit der Frage- und Antwortrunde. Insgesamt 60 Minuten. Den Anfang macht die Fraktion der CDU/CSU mit zehn Minuten und die Kollegin Astrid Timmermann-Fechter hat das Wort.

Abg. **Astrid Timmermann-Fechter** (CDU/CSU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich beginne mit zwei Fragen an Herrn Hener: Warum bewertet das Deutsche Rote Kreuz die 18-monatige Ausbildung als geeignet, um den Personalbedarf effizient zu decken? Worin liegen die Vorteile gegenüber einer zweijährigen oder einer einjährigen Ausbildung?

Und die zweite Frage an Herrn Hener: Wie bewertet das Deutsche Rote Kreuz die vorgesehenen Möglichkeiten zur Verkürzung der Pflegefachassistentenausbildung und welche Chancen ergeben sich daraus für die Ausbildungsqualität und Versorgungssicherheit?

Christian Hener (Deutsches Rotes Kreuz e. V.): Vielen Dank, Frau Abgeordnete, für die Fragen.

Zur 18-monatigen Ausbildung habe ich schon im Eingangsstatement gesagt, dass wir diese befürworten, weil wir sehen, dass ein Heilberuf nicht in einem Jahr geregelt werden kann. Gleichzeitig ist aber auch die große Not in der Praxis, das QN 3 als Qualifikationsniveau der Pflegefachassistenten aufzubauen. Dafür spricht beispielsweise auch das Personalbemessungsinstrument in der stationären

Langzeitpflege, was auch schon besprochen wurde, in dem die Qualifikationsniveaus aktuell mit den einjährig Qualifizierten besetzt werden. Da wäre es wünschenswert, dass man schnell zum QN 3-Niveau kommt. Aus unserer Sicht ist das genau der richtige Mix aus Effektivität, Qualität und Effizienz, damit es auch bedeutend schneller geht, als wenn wir jetzt eine zweijährige Ausbildung hätten.

Die zweite Frage habe ich inzwischen schon vergessen, Entschuldigung.

Abg. **Astrid Timmermann-Fechter** (CDU/CSU): Wie bewertet das Deutsche Rote Kreuz die vorgesehenen Möglichkeiten zur Verkürzung der Pflegefachassistentenausbildung und welche Chancen ergeben sich daraus für die Ausbildungsqualität und Versorgungssicherheit?

Christian Hener (Deutsches Rotes Kreuz e. V.): Ja, vielen Dank.

Wir sehen große Chancen darin. Das ist auch das, was ich mit Aufstiegsmöglichkeiten auch für berufserfahrene Kolleginnen und Kollegen aus der Praxis meinte. Damit auch die ganze Vorerfahrung, die schon während der praktischen Zeit gesammelt wurde, belohnt wird, indem diese anerkannt und die Ausbildung effektiv auf beinahe ein Jahr oder auf ziemlich genau ein Jahr verkürzt werden kann. Das sehen wir als sachgerecht an und halten das auch für qualitativ vertretbar.

In einer idealen Welt ist natürlich immer mehr Zeit für Ausbildung und Lernen wünschenswert, aber angesichts des Fachkräftemangels sehen wir hier das ganz klare Erfordernis und auch die Rechtfertigung dafür, dass es möglich ist, diese Ausbildungsverkürzung durchzuführen.

Abg. **Astrid Timmermann-Fechter** (CDU/CSU): Herzlichen Dank. Dann habe ich eine Frage an Frau Owczarek: Wie bewerten Sie in dem Gesetz die vorgesehenen drei Pflichteinsätze in der Akutpflege, Langzeitpflege und in der ambulanten Pflege? Welche Chancen sowie



Herausforderungen ergeben sich daraus für die Qualität der Wissensvermittlung und die Ausbildungspraxis?

Dann habe ich eine Frage an Frau Traub: Inwiefern stärken die vorgesehenen Regelungen zur Anrechnung von Berufserfahrung sowie zur Anerkennung ausländischer Berufsqualifikation die Durchlässigkeit der Ausbildungs- und Berufswege? Wie können diese Regelungen dazu beitragen, den Pflegebereich auch international attraktiver zu machen?

Katharina Owczarek (Diakonie Deutschland, Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V.): Vielen Dank für die Frage. Aus unserer Sicht ist die Aufteilung der Einsätze dringend notwendig, um die generalistische Ausbildung sicherzustellen. Deshalb ist es aus unserer Sicht von großer Bedeutung, dass die Pflichteinsätze in der ambulanten, in der akuten und in der stationären Langzeitpflege stattfinden. Dennoch sind 18 Monate, was die Pflichteinsätze angeht, kurz bemessen. Deshalb haben wir uns als Diakonie dafür ausgesprochen, dass der freiwillige Einsatz von 160 Stunden nicht gestrichen werden soll, damit mehr Zeit für den Einsatz beim Träger der praktischen Ausbildung zur Verfügung steht.

Anna Traub (Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.): Vielen Dank für die Frage. Im Moment kommen für Pflegekräfte mit im Ausland erworbenen Qualifikationen, die nicht dem Niveau der Pflegefachkraft entsprechen, zu den ohnehin vorhandenen Hürden des Anerkennungsprozesses noch die Vielfalt der unterschiedlichen Ausbildungsniveaus in den Bundesländern hinzu. Das ist eine zusätzliche Schwierigkeit. Hier bringt die Vereinheitlichung auf jeden Fall eine Erleichterung. Ihre Frage richtete sich aber konkret an die Verkürzung. Ja, das ist allgemein eine Absenkung der Hürde. Hinzu kommt das Erfordernis der Sprachkenntnisse für ausländische Fachkräfte, die sie entweder im Ausland oder im Inland erwerben müssen. Das verlängert den Prozess. Die Aussicht auf einen dann verkürzten Lernprozess ist daher eine Absenkung und führt – so ist zu hoffen – in manchen Fällen dazu, dass nicht der Weg in die ungelernte Hilfskrafttätigkeit gewählt wird –

sofern die Personen bereits im Inland sind, wie Geflüchtete –, sondern der anspruchsvolle Weg einer Anerkennung. Auch aus dem Ausland heraus können so erleichterte Zugänge geschaffen werden, was dem großen Bedarf an Pflegefachassistentenkräften in Zukunft entgegenkommt, wenn der Zugang insgesamt leichter wird. Vielen Dank.

Abg. **Astrid Timmermann-Fechter** (CDU/CSU): Ich habe noch eine Frage an Herrn Hener. Inwiefern führen die Harmonisierung der Start- und Endzeitpunkte sowie der Ausbildungsinhalte der Pflegefachassistentenausbildung mit der Pflegefachausbildung zu mehr Durchlässigkeit und Flexibilität im Ausbildungssystem und warum wird dies als positiver Gestaltungsfreiraum für die Pflegeschulen gewertet?

Christian Hener (Deutsches Rotes Kreuz e. V.): Vielen Dank für die Frage, Frau Abgeordnete. Das ist genau das, was die Kollegin von der AWO-Pflegeschule in ihrem Eingangsstatement erwähnt hatte. Nach Landesrecht sind die Start- und Endzeitpunkte der Pflegefachausbildung und der derzeit bestehenden Pflegehelferausbildungen nicht kompatibel. Das liegt beispielsweise daran, dass jemand, der die 18-monatige Pflegefachassistentenausbildung erfolgreich abgeschlossen hat und anschließend direkt in das zweite Ausbildungsjahr der Pflegefachausbildung einsteigen möchte – was über ein Anerkennungsverfahren möglich ist –, häufig auf ein zeitliches Problem stößt. Wenn etwa das Land festlegt, dass sowohl die Pflegefachassistentenausbildung als auch die Pflegefachausbildung im Oktober beginnen, entsteht eine Lücke von etwa einem halben Jahr, bis der Übergang von der Pflegefachassistentenausbildung in die Pflegefachausbildung möglich ist. Daher wäre es aus unserer Sicht begrüßenswert, wenn die Pflegeschulen die Möglichkeit hätten, die Start- und Endzeitpunkte der jeweiligen Ausbildung selbst zu bestimmen, damit ein harmonischer Übergang zwischen den Ausbildungsgängen erfolgen kann.

Abg. **Astrid Timmermann-Fechter** (CDU/CSU): Ich glaube, wir schaffen noch eine Frage, Herr Hener. Welchen Beitrag leistet die Einführung der Pflegefachassistentenausbildung in Bezug auf höhere Bildungschancen und



Aufstiegsmöglichkeiten, insbesondere für Menschen mit beruflicher Vorerfahrung und geringer formaler Qualifikation?

Christian Hener (Deutsches Rotes Kreuz e. V.): Vielen Dank auch für die Frage. Das Pflegefachassistenzgesetz sieht umfangreiche Möglichkeiten zur Anerkennung von Berufserfahrung und anderen Vorerfahrungen vor. Das begrüßen wir sehr, weil das zu mehr Aufstiegsmöglichkeiten führt, da man nicht die ganze Pflegefachausbildung von vorne beginnen muss. Es gibt unterschiedliche Modelle, von Verkürzungen bis hin zu sogenannten Vorbereitungskursen, die auf 320 Stunden eine stark verkürzte Ausbildung darstellen. Gleichzeitig bestehen niedrigschwellige Einstiegsmöglichkeiten für Zielgruppen, die bisher keinen systematischen Zugang zu einer Pflegeausbildung hatten. Dadurch eröffnet sich die Möglichkeit, das gesamte Pflegebildungssystem durchlässiger zu gestalten. Hier ist vorhin das Stichwort BAPIT gefallen. In einem solchen Modell kann man sich theoretisch von der Pflegefachassistenz bis hin zum Professor für Pflegewissenschaft weiterqualifizieren. Das sehen wir als große Bildungschance und begrüßen auch die Ausnahmemöglichkeiten, beispielsweise ohne Hauptschulabschluss mit einer Eignungsprognose. Bildungsbiografien sind individuell, und der fehlende Schulabschluss darf kein ausschlaggebendes Kriterium für den weiteren Berufsweg sein.

Die **Vorsitzende**: Ganz herzlichen Dank. Das kann ich angesichts von 60.000 Jugendlichen, die jedes Jahr ohne Abschluss bleiben, nur unterstreichen. Wir gehen dann weiter zur Fraktion der AfD. Sie haben sieben Minuten Zeit für Fragen und Antworten. Herr Reichardt macht sich schon bereit.

Abg. **Martin Reichardt** (AfD): Meine erste Frage geht an Frau Edenharter. Folgende Situation: Es ist im Bereich der Pflegehelfer so, dass diese sich zu einem erheblichen Teil aus einem Personenkreis speisen, der aufgrund unterschiedlichster vorheriger Lebensverhältnisse in diesen Bereich der Pflege gegangen ist und an einer weiteren Ausbildung gar nicht in diesem hohen Maße interessiert ist, sondern einfach diese Arbeit dort erledigen will. Das wird auch in der Pflege so

anerkannt, dass das Menschen sind, die aus bestimmten Motivationen heraus diese Tätigkeiten und die Arbeit mit Menschen machen wollen. Jetzt setzen wir mit der Pflegefachassistenz darauf, eine Durchlässigkeit zu schaffen, was grundsätzlich auch gut ist. Vor diesem Hintergrund hätte ich zwei Fragen:

Erstens: Soll der Pflegehelfer, ich sage mal, als unterste Ebene der Pflege, erhalten bleiben und im gleichen Umfang gefördert werden?

Und zweitens: Welches Gesamtvolumen sehen Sie überhaupt dahingehend, wie viele Pflegefachassistenz-Auszubildende man überhaupt wird gewinnen können, insbesondere vor dem Hintergrund, dass jemand, der eine Ausbildung machen will, ja grundsätzlich auch direkt die Ausbildung zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau beginnen kann?

Kathrina Edenharter (Deutscher Pflegerat e. V.): Vielen Dank für die Frage. Zur Frage 1: Wir begrüßen die kulturelle Vielfalt, die auch zur Versorgung der vulnerablen Gruppen gehört. Die Bezeichnung „unterste Ebene“ würde ich so nicht wählen. Und zur Frage 2: Genaue Kennzahlen kann ich nicht vorlegen. Danke.

Abg. **Martin Reichardt** (AfD): Ich hatte zur kulturellen Situation überhaupt nichts gesagt. Es ging ausschließlich darum, ob diese Ebene so weiter gefördert werden soll. Das wollte ich nur noch mal klarstellen.

Die nächste Frage geht an Frau Traub. Auf Seite 3 des Gesetzentwurfs wird die Anerkennungsregelung für ausländische Berufsqualifikationen relativ kurz abgehandelt, die aber gerade im Kontext der Fachkräfteanwerbung ein sehr relevanter Punkt sein wird. Sehen Sie hier Änderungsbedarf, und wenn ja, in welcher Weise?

Anna Traub (Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.): Wie gesagt, uns war eine vertiefte Befassung in den Gremien des Deutschen Vereins nicht möglich. Deswegen kann ich nur



aus unserer Diskussionskultur und aus meiner persönlichen Einschätzung heraus antworten. Können Sie die Frage noch mal kurz wiederholen? Entschuldigung.

Abg. **Martin Reichardt** (AfD): Ja. Wie gesagt, im Gesetzentwurf sind diese Anerkennungsregelungen relativ kurz abgehandelt worden. Aber die Fachkräftenwerbung soll ja ein wesentlicher Bestandteil sein. Sehen Sie da in den Formulierungen Ergänzungs- bzw. Änderungsbedarf?

Anna Traub (Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.): Genau. Zunächst würde ich keinen Ergänzungs- oder Änderungsbedarf sehen. Natürlich erscheint es uns schlüssig, wie von manchen anderen Verbänden gefordert, das eine oder andere Kriterium zu präzisieren. Aber grundsätzlich ist das Anerkennungsverfahren im Anerkennungsgesetz geregelt. Das sind hier nur ergänzende Klarstellungen. Insofern würde ich aus meiner fachlichen Sicht erst mal keinen Änderungsbedarf konstatieren.

Abg. **Martin Reichardt** (AfD): Gut, dann habe ich noch drei Minuten. Ich hätte eine Frage an Frau Owczarek: Auf Seite 98 des Gesetzentwurfes heißt es: „Von der Assistentenausbildung und der Einstiegsqualifizierung können insbesondere Personen mit geringer Schulbildung profitieren, die auch zur Zielgruppe der neuen Ausbildung gehören.“ Sehen Sie hier nicht das Risiko, dass sich der geringe Schulbildungsstand spätestens im Rahmen der Pflegeassistententätigkeiten in irgendeiner Weise problematisch auswirkt, insbesondere im Hinblick auf die Durchlässigkeit und mögliche Aufstiegschancen nach oben?

Katharina Owczarek (Diakonie Deutschland, Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V.): Vielen Dank für die Frage. Aus unserer Sicht ist der Zugang auch für Menschen ohne Berufsabschluss von wesentlicher Bedeutung, um Bildungschancen zu gewähren. Die Eignung an sich hat nichts damit zu tun, ob der Berufsabschluss tatsächlich vorliegt. Wir halten es auf jeden Fall für notwendig, um auch die Durchlässigkeit in die Pflegefachkraftausbildung zu gewährleisten, dass in den Ländern im Rahmen der

Pflegefachassistentenausbildung die Möglichkeit besteht, einen allgemeinen Berufsabschluss zu erlangen.

Abg. **Martin Reichardt** (AfD): Danke. Dann noch eine letzte Frage an Frau Ebenharter. Die Frage ist ja letzten Endes, wenn wir eine Ausbildung schaffen, die einen Pflegehelfer, eine Pflegefachassistentin, eine Pflegefachkraft und dann auch noch eine mit Studium weiterqualifizierte pflegerische Fachkraft umfasst, wo Sie da genau die Abgrenzungsfelder innerhalb dieses breiten Spektrums an Ausbildungen sehen. Wo unterscheiden die sich?

Katharina Edenharter (DPR): Katharina Ebenharter für den Deutschen Pflegerat. Die Kompetenzen müssen klar abgegrenzt werden. Die Pflegefachpersonen müssen eng mit den Pflegefachassistenten und -assistentinnen verzahnt sein. Dieser Katalog sollte sicherlich geklärt werden, allerdings nicht in zu kleinteiliger Form. Vielen Dank.

Die **Vorsitzende**: Vielen Dank. Dann kommen wir zur Fraktion der SPD mit sechs Minuten. Sabine Dittmar macht den Aufschlag.

Sabine Dittmar (SPD): Ja, danke schön, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage geht an Frau Owczarek von der Diakonie. Ich komme nochmal auf die Problematik der Ausbildungsduldung zu sprechen und möchte Sie bitten, uns nochmal die Hürden darzulegen, die derzeit für die Ausbildungsduldung in der Pflegeassistenten bestehen. Und vor allem, mit welchen gesetzlichen oder auch untergesetzlichen Regelungen wir diesen begegnen können.

Katharina Owczarek (Diakonie Deutschland, Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V.): Vielen Dank für die Frage. Im Bereich der Ausbildungsduldung haben wir das Problem, dass in § 16d Aufenthaltsgesetz vorgesehen ist, dass Asylbewerber oder Menschen mit ungeklärten Aufenthaltstiteln der Aufenthalt zur Pflegefachassistentenausbildung nur gewährt wird, wenn gleichzeitig auch feststeht, dass eine Zusage für eine Pflegefachkraftausbildung besteht. Das ist ein



großes Problem angesichts der Tatsache, dass wir zukünftig Pflegehilfskräfte in großer Zahl benötigen. Von daher sollte man hier ansetzen und vor allem – so glaube ich – wäre es die einfachste Lösung, die Pflegefachassistentenausbildung in § 2 Aufenthaltsgesetz als qualifizierte Berufsausbildung anzuerkennen.

Abg. **Claudia Moll** (SPD): Vielen Dank. Meine Frage geht an Frau Kalberlah, Akademie der AWO. Sehr geehrte Frau Kalberlah, Sie haben die Schwierigkeit betont: Genügend qualifiziertes Lehrpersonal für die neue Ausbildung zu gewinnen. Welche kurzfristigen Übergangslösungen sehen Sie, bis ausreichend neue Pflegepädagogen verfügbar sind?

Isabel Kalberlah (Hans-Weinberger-Akademie der AWO e. V.): Sehr geehrte Frau Moll, vielen Dank für die Frage. Wir haben angesichts der Pflegepädagogikstudiengänge zu wenig Studienplätze. Das heißt, wir brauchen unbedingt auch für Studierende Genehmigungen, die sich bereits im Studium befinden, um hier überbrücken zu können. Wir benötigen weiterhin den Bestandsschutz für die Lehrenden, die bereits an den Pflegeschulen, Altenpflegehilfeschulen und Krankenpflegehilfeschulen unterrichten. Und wir brauchen auch noch eine Übergangsregelung, im besten Falle einen Bestandsschutz für die Studierenden, die bereits jetzt ein Studium der Pflegepädagogik/Medizinpädagogik aufgenommen haben. Wir haben ja die Möglichkeit, bis 2035 landesrechtliche Regelungen zu erweitern. Wir haben bereits die Möglichkeit, das für den theoretischen Unterricht auf Landesebene zu tun. Wir brauchen dies aber gleichzeitig auch für den fachpraktischen Unterricht.

Abg. **Sabine Dittmar** (SPD): Meine Frage geht an Frau Edenharter vom Deutschen Pflegerat. Frau Edenharter, Frau Walch hat uns gerade sehr eindrucksvoll geschildert, wie leistungsfähig die Reha-Einrichtungen sind, auch bezüglich der Pflegeausbildung. Wir bekommen von der Exekutive immer mitgeteilt, dass diese Reha-Einrichtungen aber nicht komplett in der Lage wären, die spezifischen Herausforderungen, die sich an einen Träger der Ausbildung richten, zu erfüllen. Sie selbst

als Pflegerat haben immer ein sehr großes Augenmerk auf die Qualität und auf den Kompetenzerwerb in der Ausbildung und unterstützen die Rehabilitationseinrichtungen als Träger der Ausbildung. Ich möchte Sie bitten, uns dies noch ein bisschen zu begründen.

Kathrina Edenharter (Deutscher Pflegerat e. V.): Wir vom DPR unterstützen eine Ausweitung auf die Reha-Träger, denn die Pflege endet nicht in einem Setting. Wir haben die Pflege im ambulanten Bereich und wir haben sie in einem klinischen Setting. Wir brauchen sie im Nachgang zur Rehabilitation, aber auch zur Prävention. Daher ist es ein Schwerpunkt und das würden wir befürworten.

Abg. **Sabine Dittmar** (SPD): Ich habe noch Zeit für eine Frage? Ja, gut, wunderbar. Dann würde ich nochmal zur Diakonie, zur Frau Owczarek wechseln und darum bitten, ob Sie uns nochmal eine Bewertung der vorgesehenen Möglichkeiten zur Anrechnung der gleichwertigen Berufserfahrungen für die Verkürzungen der Ausbildungsdauer geben können.

Katharina Owczarek (Diakonie Deutschland, Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V.): Meinen Sie die Möglichkeit zur Anrechnung für die ausländischen Pflegekräfte? Sie meinen für die beruflich Erfahrenen, genau. Dies sehen wir generell sehr positiv. Wir halten es für dringend notwendig, dass die berufserfahrenen Pflegehilfskräfte, die zwar nicht ausgebildet sind, aber seit Jahren in den Einrichtungen arbeiten, die Möglichkeit einer formalen Berufsqualifikation erhalten. Möglichst schnell sollten die Erfahrungen aus den Pflegeeinrichtungen genutzt werden, um ausgebildete Pflegehilfskräfte für die Personalbemessung zu gewinnen. Die Erfahrungen zeigen, dass viele Berufserfahrene durch externe Prüfungen das Qualifikationsniveau der ausgebildeten Pflegefachkräfte zügig erreichen. Daher halten wir das für wesentlich, dringend notwendig und ausreichend.

Die **Vorsitzende**: Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN mit acht Minuten. Simone Fischer hat das Wort.



Abg. **Simone Fischer** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Guten Tag in die Runde. Meine erste Frage geht an Frau Edenharter vom DPR. Nochmal zu Ihrer Stellungnahme, die Sie zuvor sehr eindrücklich beschrieben haben, insbesondere in Bezug auf die zweijährige Ausbildung, für die Sie sich ausgesprochen haben. Vielleicht können Sie in dem Zusammenhang noch mal konkret auf Ihre Punkte eingehen, die die Patientensicherheit betreffen.

Und in einer zweiten Frage würde mich interessieren, welche Chancen und Herausforderungen Sie darin sehen, den Ländern die Möglichkeit zu geben, ergänzend allgemeinbildenden Unterricht und gezielte Sprachförderung in die Ausbildung zu integrieren, auch wenn dies zu einer längeren Ausbildungsdauer führen könnte.

Kathrina Edenharter (Deutscher Pflegerat e. V.): Vielen Dank für die Frage. Wir befürworten die zweijährige Ausbildung und sehen eine Verkürzung daher skeptisch, weil die Berufsausbildung für Pflegefachassistenten dem DQR-Niveau 3 entsprechen sollte, damit anschließend der Aufstieg auf DQR-Niveau 4 zur Pflegefachperson möglich ist. Und die Verkürzung der Ausbildung – etwa durch die Anrechnung von Berufserfahrung – gefährdet auch die Vermittlung wichtiger Kompetenzen und senkt unserer Meinung nach das Ausbildungsniveau. Denn die Kompetenz entsteht nicht allein durch die Praxis, sondern durch das Zusammenspiel von Theorie, Praxis und Reflexion. Und nur eine zweijährige Ausbildung stellt sicher, dass die Pflegefachassistenten ein verlässliches Niveau erreichen und damit auch die Patientensicherheit gewährleistet wird.

Wir haben gerade auch nochmal über eine Verkürzung gesprochen, 18 oder 12 Monate, ich schließe 12 Monate für mich aus, ich denke auch für den DPR, aber auch die 18 Monate sehen wir insofern kritisch, denn was möchten wir diesen Menschen beibringen? Wir möchten Menschen integrieren und sind auf die Menschen aus dem Ausland mit angewiesen. Wir möchten jetzt noch einen Schulabschluss integrieren und/oder auch nicht. Und wer schafft in 18 Monaten einen generell allgemein gültigen Schulabschluss oder dieses Niveau plus eine Fachexpertise, um dann auf DQR-

Niveau 4 den Zugang zur Pflegefachperson zu erhalten? Deshalb drängen wir darauf, die zweijährige Ausbildungsdauer zu halten. Denn auch wenn wir über Pflichteinsätze sprechen oder das Niveau erweitern, stellt sich die Frage, in welchem Feld diese Menschen ihre fachliche Expertise erlangen sollen. Es gibt eine Grundexpertise und auch eine fachliche Spezialisierung dafür. Und die benötigt Zeit. Diese Zeit ist notwendig, um die Patientensicherheit zu schützen. Wir brauchen diese Sicherheit und nicht das Füllen einer Lücke. Die Frage zwei habe ich jetzt vergessen.

Abg. **Simone Fischer** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Die bezog sich auf die Chancen und Herausforderungen, den Ländern die Möglichkeit zu geben, ergänzend allgemeinbildenden Unterricht und gezielte Sprachförderung in die Ausbildung zu integrieren, auch wenn dies zu einer längeren Ausbildungsdauer führen könnte, eben aufgrund fehlender Sprachkenntnisse, die in der Praxis häufig als Hauptgrund für Ausbildungsabbrüche genannt werden.

Kathrina Edenharter (Deutscher Pflegerat e. V.): Wir sehen eine Chance darin. Auszubildende mit geringem schulischem Vorwissen benötigen eine besondere Unterstützung, also Maßnahmen wie Schulsozialarbeit, individuelle Lernbegleitung oder eine gezielte Sprachförderung. Diese Basiskompetenzen sind hilfreich. Die Strukturen verringern die Überforderung und sollen dann in der Folge zu weniger Abbrüchen führen. Und natürlich müssen dabei auch die didaktischen Anforderungen und der personelle Aufwand berücksichtigt werden. Es muss die weitreichende pädagogische und diagnostische Kompetenz, die erforderlich ist, gestellt werden. Und der DPR spricht sich deutlich für die Reduzierung der Anzahl der Ausbildungsplätze pro hauptberufliche Lehrkraft aus. Denn das Verhältnis sollte mindestens einer Vollzeitstelle auf zehn Ausbildungsplätze entsprechen, anstatt wie im aktuellen Entwurf 1:20. Das wäre deutlich förderlicher. Danke.

Abg. **Simone Fischer** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Vielen Dank. Dann habe ich noch eine Frage. Sie hatten zuvor bereits die Positivprognose der Pflegeschulen erwähnt. Können Sie konkrete



Kriterien nennen, die es ermöglichen, Prognoseentscheidungen bundesweit transparent, nachvollziehbar und verbindlich zu gestalten und so mehr Verbindlichkeit zu schaffen?

Kathrina Edenharter (Deutscher Pflegerat e. V.): *[Mikro kurz aus]* ... die Prognoseentscheidung der Schulen, das reicht nicht aus. Wie soll eine Schule eine potenzielle Auszubildende oder einen potenziellen Auszubildenden beurteilen, die oder den man vielleicht zum ersten Mal sieht – oder nur anhand von Unterlagen? Das widerspricht dem hohen Stellenwert zwischenmenschlicher Kompetenzen, die in der Pflege zentral sind. Wir sprechen uns gegen die im Gesetzentwurf vorgesehene Prognosestellung aus. Die Mindestvoraussetzung sollte ein Hauptschulabschluss, ein gleichwertiger Abschluss oder eine abgeschlossene Berufsausbildung sein. Das ist zwar nicht perfekt, aber deutlich besser als eine Prognose. Aus der Praxis kann ich berichten: Man schafft Umwege. Wenn eine Schule eine Prognose stellt und dabei eigene oder uneinheitliche Kriterien anlegt, führt das nicht zu niedrigeren Hürden für die Auszubildenden. Stattdessen werden sie in einer anderen Form eines Prüfstandes erneut geprüft, ob sie sich im praktischen Alltag tatsächlich integrieren lassen. Wir sehen von der Prognose ab.

Abg. **Simone Fischer** (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN): Ich habe noch eine Frage an Sie, Frau Traub. Sie hatten in Ihrem Eingangsstatement schon darauf hingewiesen, dass Sie empfehlen, dass die Bund-Länder-Gruppe Vorschläge machen soll, um die Finanzierung der Pflegefachassistentenausbildung zu regeln. Vor dem Hintergrund Ihrer Empfehlung zur nachhaltigen Finanzierung der Pflege haben Sie sich sicher schon mit Ihren Mitgliedern dazu ausgetauscht. Welche Ansätze halten Sie für sinnvoll, um die Ausbildung zu finanzieren und gleichzeitig die pflegebedingten Eigenanteile wirksam zu begrenzen?

Anna Traub (Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.): Die Diskussion im Deutschen Verein spiegelt ein Stück weit die Entwicklung der gesellschaftlichen Diskussion wider. Im kurzen Rückblick: In den Stellungnahmen der vergangenen 15 Jahre hat der Deutsche Verein, der

diese Regelung von Anfang an kritisiert hat, bereits alle möglichen Varianten durchgespielt – von der Übernahme ins Schulrecht bis hin zur verstärkten Finanzierung durch die Länder. Das ist inzwischen nicht mehr aktuell. Derzeit gibt es eine Arbeitsgruppe zur grundsätzlichen Pflegereform und es zeichnet sich ab, ohne dass das bereits Beschlusslage wäre, dass es auch in unseren Gremien eine Dominanz für den Zuschuss aus Steuermitteln gibt. Das ist im Moment der dominierende Vorschlag, plus eine Erhöhung des Anteils der Länder. Aber wie gesagt, das sind keine Beschlusslagen. Das sind im Moment noch Diskussionen.

Die **Vorsitzende**: Herzlichen Dank. Dann kommen wir zur Fraktion Die Linke. Sie haben sechs Minuten für Ihre Fragen und Antworten. Bitte, Frau Stange.

Abg. **Julia-Christina Stange** (Die Linke): Vielen Dank. Vielen Dank auch, dass ich heute hier in der Runde als Sprecherin für Ausbildungsberufe im Gesundheitswesen sein darf. Ich selbst war bis März noch Pflegefachkraft an der Uniklinik in Mainz. Also noch frisch hier. Umso mehr interessiert mich auch eine wirklich gute Gesetzgebung. Wenn wir jetzt schon die Chance haben, was wir alle sehr betont haben, der Pflege wirklich mal zu helfen, dann schließt das mittlerweile viele Berufsgruppen mit ein, die unter dem Begriff Pflege zusammengefasst werden. Daher auch meine erste Frage an die Gewerkschaft ver.di, an Frau Wehrheim: Was sagen Sie zu den Schutzrechten – das haben wir heute noch gar nicht erwähnt – und der Möglichkeit der betrieblichen Mitbestimmung für die Auszubildenden?

Melanie Wehrheim (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di): Vielen Dank für die Frage. Aus unserer Sicht ließen sich die Schutzrechte für die Auszubildenden am besten mit einer Regelung nach dem Berufsbildungsgesetz gestalten. Zumindest muss das Ausbildungsverhältnis aus unserer Sicht konsequent arbeitsrechtlich im Betrieb verankert sein. Das ist wichtig, damit die Auszubildenden über ihre Interessenvertretung Einfluss auf ihre Ausbildungsbedingungen nehmen können. Und es muss aus unserer Sicht auch



sichergestellt sein, dass der Träger der praktischen Ausbildung als Vertragspartner der Auszubildenden den beherrschenden Einfluss auf die Gestaltung der Ausbildung hat, also die Ausbildung verantwortlich gestaltet. Wir wissen von vielen Problemen aus der Praxis. Umso wichtiger ist es, dass die Möglichkeit der betrieblichen Mitbestimmung gegeben ist. Gerade in vielen größeren Einrichtungen gibt es Jugend- und Auszubildendenvertretungen. Hier ist uns ein Punkt besonders wichtig: Wir wissen zwar, dass aus den Rechtsgrundlagen die JAV-Arbeit geschützt ist, aber es gibt immer wieder Probleme bei den Heilberufen mit der strengen Fehlzeitenregelung, wo wir grundsätzlich meinen, dass sie abzuschaffen ist. Zumindest sollte doch sichergestellt sein, dass die JAV-Arbeit umfassend geschützt ist, auch während des theoretischen und praktischen Unterrichts. Danke schön.

Abg. **Julia-Christina Stange** (Die Linke): Unbedingt. Vielen Dank für die Antwort. Sehr wichtig. Eine zweite Frage auch noch an die Gewerkschaft ver.di: Wir haben jetzt viel darüber gehört. Reicht denn die Regelung im Gesetzentwurf aus, wonach die Länder regeln können, dass parallel zur Ausbildung für Auszubildende ohne Schulabschluss die Möglichkeit bestehen kann, den Hauptschulabschluss zu erwerben?

Melanie Wehrheim (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di): Vielen Dank für die Frage. Wir wünschen uns hier sehr, dass es eine entsprechende Klarstellung im Gesetzestext gibt. Es gibt entsprechende Vorschläge der Länder. Wir halten es für sehr wichtig, dass im Zusammenhang mit der Assistenzausbildung ein allgemeinbildender Schulabschluss, möglichst die mittlere Reife, ermöglicht wird, um entsprechende berufliche Entwicklungsmöglichkeiten zu schaffen.

Abg. **Julia-Christina Stange** (Die Linke): Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an die Diakonie, an Frau Owczarek. Sprachkenntnisse sind eine wesentliche Voraussetzung, sie sind der Schlüssel für alles, auch für die Arbeit in der Pflege. Was schlagen Sie vor, um diese Förderung wirklich zu verbessern und für alle auch machbar zu machen?

Katharina Owczarek (Diakonie Deutschland, Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V.): Aus unserer Sicht ist vor allem die Finanzierungsgrundlage für mögliche Sprachkurse für die Pflegefachassistenten zu ermöglichen. Das habe ich schon im Eingangsstatement gesagt, dass wir hier auf jeden Fall eine Finanzierungsgrundlage im Pflegeberufgesetz benötigen. In vielen Projekten, zum Beispiel in Hessen mit der „Pflegehelfer Ausbildung Plus“, werden zusätzliche Sprachtrainings und individuelle Sprachkurse angeboten. Also gibt es schon in der Fläche viele und vielfältige Möglichkeiten. Entscheidend ist, dass die Refinanzierung sichergestellt wird. Derzeit ist das über den Ausbildungsfonds überhaupt nicht gewährleistet.

Abg. **Julia-Christina Stange** (Die Linke): Vielen Dank. Eine zweite Frage an Sie. Die Schulsozialarbeit, ein wirklich wesentlicher Bestandteil und Baustein, um den Abbruch zu vermeiden. Wie bewerten Sie die Möglichkeit zur festen Einbindung der Schulsozialarbeit?

Katharina Owczarek (Diakonie Deutschland, Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V.): Wir würden auf jeden Fall die Schulsozialarbeit, wie sie auf den allgemeinbildenden oder an den normalen Schulen schon existiert, für sehr wichtig erachten. Das wäre aus unserer Sicht am effektivsten und am wichtigsten.

Abg. **Julia-Christina Stange** (Die Linke): Vielen Dank. Meine letzte Frage geht an den Pflegerat, an Frau Edenharter. Ist Ihnen die Abgrenzung der einzelnen Pflegeausbildungen im Gesetz klar genug formuliert? Es gibt nun die akademische Ausbildung, die duale Ausbildung und jetzt die Pflegefachassistentenausbildung. Wie ist das mit der Aufgabenbegrenzung? Ich lese immer Worte wie „komplex“ und „nicht komplex“. Was ist Ihre Meinung dazu?

Katharina Edenharter (Deutscher Pflegerat e. V.): Vielen Dank für die Frage. Komplex, hochkomplex und weniger komplex ist tatsächlich immer wieder ein Definitionspunkt. Wir würden es vorziehen, uns schrittweise heranzuarbeiten, zunächst mit dem Pflegefachassistentengesetz und



anschließend mit der Erweiterung der Befugnisse. Ich möchte nochmal betonen, dass es um eine grundsätzlich gemeinschaftliche Basis geht, einen gemeinschaftlichen Grundstock, der dann weiterwachsen kann. Der Katalog der Tätigkeiten oder die Unterschiede werden sicher auch über die Heilkunde definiert, beziehungsweise die Heilkunde wird hier die Definition schaffen. Daher brauchen wir zunächst diese Basis, die geschaffen werden muss, um anschließend zum Skillmix führen zu können. War das verständlich?

Abg. **Julia-Christina Stange** (Die Linke): Für mich ja. Vielen Dank.

Die **Vorsitzende**: Vielen Dank. Dann kommen wir in die zweite Runde. Die Fraktion CDU/CSU hat nochmals 10 Minuten Zeit. Frau Janssen, bitte.

Abg. **Anne Janssen** (CDU/CSU): Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine Fragen richten sich an Frau Walch vom Bundesverband Deutscher Privatkliniken. Frau Walch, im § 14 des Pflegeberufgesetzes ist ja schon geregelt, dass die Privatkliniken, also die Reha-Einrichtungen, Modellvorhaben aufrufen können, um in der Pflegefachkraftausbildung aktiv zu werden. Warum ist das bis heute noch nicht passiert? Können Sie das erläutern? Um sich eben auch jetzt im Vorgriff auf die Assistenzausbildung bereits zu beweisen, dass sie schon mal zeigen können, dass man es wirklich kann. Warum ist dieses Modellvorhaben noch nicht durchgeführt worden?

Antonia Walch (Bundesverband Deutscher Privatkliniken e. V.): Vielen Dank für die Frage. Zum einen liegt das daran, dass Modellvorhaben zeitlich befristet sind, einen sehr hohen Aufwand haben und völlig ungewiss ist, ob es dann nachher übernommen wird, was oft eher nicht der Fall ist. Zum anderen hat in Niedersachsen bereits eine Reha-Einrichtung einen Antrag auf ein solches Modellvorhaben gestellt, der jedoch vom Ministerium abgelehnt wurde. Ich habe leider nicht herausgefunden, warum. Und zum dritten haben wir neurologische und geriatrische Einrichtungen mit Krankenhausbetten, die bereits jetzt schon Pflegeausbildung durchführen. Da kann man schon mal sehr gut sehen, dass es funktioniert.

Abg. **Anne Janssen** (CDU/CSU): Ich habe noch eine Frage zur Finanzierung, denn Sie müssen ja als Träger in den Ausbildungsfonds mit einzahlen. Das muss dann neu geregelt werden. Wie bewerten Sie die Bereitschaft Ihrer Einrichtungen diesbezüglich? Wie würde der BDPK dies lösen?

Antonia Walch (Bundesverband Deutscher Privatkliniken e. V.): Grundsätzlich sind die Reha-Kliniken in jedem Fall dazu bereit. Es sind auch viele, die gerne selbst ausbilden möchten. Ich weiß, dass das BMAS, also das Arbeitsministerium, mit der Rentenversicherung auch schon einmal darüber gesprochen hat. Wir haben eine ganz andere Finanzierung in der Rehabilitation, das ist ja eine monistische Finanzierung. Die würden, glaube ich, eher vorschlagen, dass man nicht in den Topf einzahlt, sondern dass die Kliniken die Ausbildung über den Vergütungssatz von den Reha-Trägern bezahlt bekommen. Aber wie gesagt, unsere Einrichtungen wären in jedem Fall bereit, sich ganz normal – wie alle anderen auch – an dieser Finanzierung zu beteiligen.

Abg. **Anne Janssen** (CDU/CSU): Eine weitere Nachfrage nochmal an Sie, Frau Walch. Wenn Sie als Träger für die medizinische Rehabilitation in Frage kommen, sehen Sie Anpassungsbedarf, um künftig auch flächendeckend ausbilden zu können? Wie müssen Sie vorbereitet werden? Gibt es in diesem Bereich überhaupt Anpassungen oder Regelungen, die vorgenommen werden müssten?

Sie haben in Ihrem Eingangsstatement vor dem Wegfall vieler Kliniken und der zunehmenden Ambulantisierung gewarnt. Wie schätzen Sie die Möglichkeiten ein, dass Reha-Einrichtungen hier entstehende Lücken auffangen und selbst Ausbildungsplätze anbieten können?

Antonia Walch (Bundesverband Deutscher Privatkliniken e. V.): Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die erste Frage richtig verstanden habe.

Abg. **Anne Janssen** (CDU/CSU): Welche Anpassungen eventuell vorgenommen werden müssten.



Antonia Walch (Bundesverband Deutscher Privatkliniken e. V.): Wir hatten noch eine Regelung. Also klar, wir müssten natürlich den § 6 – § 6 ist das, glaube ich – anpassen, dass auch die Reha-Einrichtungen Ausbildungsträger sein dürfen. Dann müsste man in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung den § 3 Absatz 2 anpassen, weil dort geregelt ist, dass die Pflichteinsätze bei einem Träger stattfinden müssten. Nach unserer Vorstellung würden die Reha-Einrichtungen 200 Stunden der vorgesehenen 400 Stunden für die Pflegefachausbildung übernehmen, also 200 Stunden in der Akutpflege und 200 Stunden in der stationären Langzeitpflege, sodass sie im Grunde auch auf die 400 Stunden kämen. So würde die Gesamtstundenzahl erfüllt, ohne dass ein Pflichteinsatz ausschließlich in der Reha-Einrichtung vorgesehen wäre. Und die zweite Frage war?

Abg. **Anne Janssen** (CDU/CSU): Mit dem Wegfall von Kliniken im Zuge der Krankenhausreform – wie können Sie das auffangen? Sie sagten eingangs auch wie viele Einrichtungen Sie deutschlandweit betreiben. Wie können Sie da die entstehenden Lücken schließen?

Antonia Walch (Bundesverband Deutscher Privatkliniken e. V.): Genau, wir denken, dass es vor allem daran liegt, dass die Reha-Einrichtungen in den ländlichen Gebieten angesiedelt sind. Wenn jetzt Krankenhäuser ganz schließen oder sich zusammenschließen müssen, entsteht dort eine Lücke, gerade im ländlichen Bereich. Durch die Reha-Einrichtungen erhalten die Menschen vor Ort weiterhin die Chance, ihre Ausbildung wohnortnah zu absolvieren.

Abg. **Astrid Timmermann-Fechter** (CDU/CSU): Ich habe noch eine Frage an Frau Owczarek. Auf welche Aspekte sollte Ihrer Meinung nach bei der Harmonisierung zwischen der neuen Pflegefachassistentenausbildung und dem Gesetz zur Befugnisweiterung und Entbürokratisierung der Pflege geachtet werden – etwa bei den Delegationsmöglichkeiten, der Abgrenzung vorbehaltener Tätigkeiten oder bei der Patientensicherheit?

Katharina Owczarek (Diakonie Deutschland, Evangelisches Werk für Diakonie und

Entwicklung e. V.): Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich versuche, sie schnell zu beantworten. Es ist so, dass zukünftig mit der Pflegefachassistentenausbildung und mit den Kompetenzen die Möglichkeit bestehen soll, vor allem im Rahmen der medizinischen Behandlungspflege auch Tätigkeiten von Ärzten oder Pflegefachkräften auf die Pflegefachassistenten zu übertragen. Für uns ist in diesem Zusammenhang vor allem wichtig, dass bei diesen Übertragungen und Delegationen die Vorbehaltsaufgaben der Pflegefachkräfte berücksichtigt werden. Im Pflegefachassistentengesetz ist jetzt geregelt, dass die Übertragung entweder durch Ärzte direkt an Pflegefachassistenten erfolgen soll oder durch Weiterdelegation durch Pflegefachkräfte. Das ist rechtlich schwer zu bewerten. Aus unserer Sicht ist eine Weiterdelegation eigentlich nicht möglich. Aufgrund der Vorbehaltsaufgaben der Pflegefachkräfte müsste eigentlich jegliche medizinische Behandlungspflege auch durch Pflegefachkräfte delegiert werden.

Die **Vorsitzende**: So, dann schließen wir die Mikrofone. Vielen Dank. Wenn von der CDU/CSU keine Fragen mehr sind, kommen wir zur Fraktion der AfD. Sie haben weitere sieben Minuten.

Abg. **Martin Reichardt** (AfD): Vielen Dank. Meine erste Frage geht an Frau Wehrheim. Es geht bei allen Berufen und Ausbildungen auch immer ein Stück weit ums Geld. Wir haben derzeit einen Abstand beim Bruttogehalt zwischen einer Pflegehelfskraft und einer Pflegefachkraft im Berufseinstieg von etwa 500 Euro. Da müsste man sich mal die Frage stellen, wo da eigentlich noch der Raum für eine sinnvolle Einbringung der Bezahlung von Pflegefachassistenten sein soll. Das Ganze muss ja auch finanziell entsprechend unterfüttert werden. Auch im Hinblick darauf, dass ein Studium der Pflegewissenschaften, ich sage das im heutigen Gehaltskanon der Pflegeberufe, wenig bis gar nichts nützt. Wie sehen Sie da die Möglichkeiten und welche Forderungen hätten Sie in diese Richtung?

Melanie Wehrheim (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di): Zur Frage der Vergütung von Pflegepersonen möchte ich darauf verweisen, dass das Anliegen der Tarifvertragsparteien ist,



die entsprechenden Eingruppierungen vorzunehmen. Von daher werden wir, wenn die neue Ausbildung auf den Weg gebracht ist und auch die Absolventen und Absolventinnen da sind, die Frage der Eingruppierung beraten. Zuständig sind da unsere entsprechenden Tarifkommissionen. Im Gesetzentwurf war die Frage der Ausbildungsvergütung angesprochen. An der Stelle ist mir wichtig zu erwähnen, dass die Annahmen, die dort getroffen sind, erstmal reine Annahmen und spekulativ sind. Ich gebe zu bedenken, dass eine Ausbildungsvergütung eine ganz wichtige Funktion zur Sicherung des Lebensunterhaltes und auch zur Fachkräftesicherung hat. Von daher streben wir an, dass es an dieser Stelle auch keine Unterschiede bei den Auszubildenden gibt.

Abg. **Martin Reichardt** (AfD): Vielleicht nochmal zur Konkretisierung. Es geht mir hier nicht um die Ausbildungsvergütung, sondern es geht mir tatsächlich um die späteren Gehaltsmöglichkeiten des Pflegehelfers, der Pflegefachassistenz und des Pflegefachpersonals. Da muss es auch irgendwelche Pläne geben, wie man hier entsprechend finanzielle Lukrativität schaffen kann. Haben Sie da Vorstellungen, wie man sowas erwirken könnte?

Melanie Wehrheim (Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di): ver.di steht für eine Aufwertung der Pflegeberufe. Wie gesagt, es ist aber eine Sache der Tarifvertragsparteien, weshalb ich an der Stelle jetzt keine konkreten Angaben machen kann.

Abg. **Martin Reichardt** (AfD): Ja, dann würde ich in ähnlicher Situation gern Herrn Feldmeier befragen. Wie sehen Sie die Möglichkeiten zum Beispiel der Kommunen, die ja in erheblichem Maße Träger sind, hier entsprechende Anpassungen vorzunehmen?

Dominik Feldmeier (Deutscher Landkreistag): Wir befürworten natürlich auch eine angemessene Entlohnung der Pflegefachassistentenkräfte, was allerdings nicht zu Kosten der Pflegebedürftigen beziehungsweise der Sozialhilfe gehen sollte.

Abg. **Martin Reichardt** (AfD): Danke. Da Sie im

Präsidium des Deutschen Pflegerates sind, Frau Edenharter: Haben Sie in dieser Hinsicht Vorstellungen? Ich möchte es nochmal betonen: Wir müssen doch gerade diesen Bereich finanziell lukrativer machen. Wenn wir einen neuen Ausbildungsberuf schaffen, dann muss er doch sinnvoll in ein Gehaltsgefüge eingruppiert werden.

Kathrina Edenharter (Deutscher Pflegerat e. V.): Vielen Dank für die Frage. Ich kann diese Frage nicht beantworten. Das war jetzt inhaltlich derzeit auch nicht der Schwerpunkt des Deutschen Pflegerates.

Abg. **Martin Reichardt** (AfD): Gut. Dann würde ich zunächst nochmal folgende Frage an Frau Traub stellen: Es geht hier im Gesetzentwurf auf Seite 2 auch um die Möglichkeit bundesweiter Mobilität. Ist es im Sinne des Personals, dass hier tatsächlich, ich sage das mal im Zweifelsfall, ein bundesweiter Konkurrenzkampf um das Pflegepersonal betrieben werden könnte? Ich sage in aller Deutlichkeit, dass zum Beispiel in Süddeutschland die entsprechenden Bezahlungen durchaus höher sein könnten als in den ost- und mitteldeutschen Bundesländern.

Anna Traub (Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V.): Ja, vielen Dank für die Frage. Der Deutsche Verein beschäftigt sich seit langem mit den Berufsbildern in der Pflege, speziell auch in den sozialen Berufen. Wir haben immer für eine weitgehende Vereinheitlichung der Berufszugänge und Ausbildungen geworben, wo das möglich ist, also dort, wo es nicht in Länderkompetenz fällt oder andere Interessen entgegenstehen. Aus fachlicher Sicht ist Mobilität gut für das gesamte System der Pflege – und auch in den sozialen Berufen, etwa in der Jugendhilfe, vergleichbar sinnvoll. Die Forschung zeigt, dass das gesamte Berufsfeld gewinnt, wenn Mobilität innerhalb des Berufsfeldes möglich ist. Den Gedanken, unterschiedliche Systeme aufrechtzuerhalten, um Konkurrenz zwischen den Bundesländern zu vermeiden und damit Mobilität zu verhindern, halte ich daher für wenig überzeugend. Soweit vielleicht erstmal, danke.



Die **Vorsitzende**: Dann haben wir in der zweiten Runde noch die Fraktion der SPD, die auch nochmal sechs Minuten Zeit hat. Sabine Dittmar.

Abg. **Sabine Dittmar** (SPD): Danke schön, Frau Vorsitzende. Meine Frage geht nochmal an Frau Owczarek von der Diakonie. Es geht nochmal um die positive Prognose bei fehlendem Schulabschluss. Da ist die Frage an Sie: Sehen Sie da weiteren gesetzlichen Nachschärfungsbedarf, vor allem, was die Handlungsmöglichkeiten für die Schulen entsprechend erleichtert, um das einheitlich zur Anwendung bringen zu können?

Katharina Owczarek (Diakonie Deutschland, Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V.): Ja, vielen Dank für die Frage. Ich hatte das schon im Eingangsstatement erwähnt. Für uns ist bei der Prognoseentscheidung wichtig, dass die Kriterien dafür nicht in den Gestaltungsspielraum der Pflegeschulen fallen, sondern dass es bundeseinheitliche Eckpunkte oder Kriterien gibt, an denen sich die Pflegeschulen orientieren sollen. Wir haben aus der Erfahrung der Länderausbildung das Problem, dass 16 Bundesländer 28 Ausbildungsgänge haben. Von daher brauchen wir hier auf jeden Fall, um eine bundeseinheitliche Vorgabe zu haben, bundeseinheitliche Kriterien.

Abg. **Claudia Moll** (SPD): Meine Frage geht an Frau Kalberlah von der Akademie der AWO. Sie weisen darauf hin, dass die 18-monatige Ausbildung nicht mit den üblichen Schulzyklen harmonisiert und dadurch Wartezeiten entstehen können. Welche Freiräume sollten die Länder den Schulen geben, um solche organisatorischen Brüche zu vermeiden?

Isabel Kalberlah (Hans-Weinberger-Akademie der AWO e. V.): Vielen Dank für die Frage. Insbesondere für Schulen, die nur einzügig ausbilden können, ergeben sich die größeren Wartezeiten, wie Herr Hener auch schon gesagt hat. Dann kann es tatsächlich bis zu einem halben Jahr dauern, in dem der Personalbedarf an den Schulen überschüssig ist und die Absolventinnen und Absolventen eine lange Wartezeit haben. Bei Schulen, die zweizügig sind, ist es dann nur ein Monat, aber auch das muss gedeckelt werden, sodass wir

zum Beispiel die Möglichkeit hätten, in vorgesehenen Korridoren die Startpunkte und die Endpunkte der Ausbildung selbst und eigenverantwortlich zu bestimmen. Das würde das Ganze harmonisieren. Der Lehrpersonalbedarf würde nicht in der Überdeckung sein, sondern die Kapazitäten könnten gut genutzt werden und auch die Absolventinnen und Absolventen hätten keine Wartezeiten.

Abg. **Sabine Dittmar** (SPD): Ich würde nochmal den Landkreistag, Herrn Feldmeier, befragen. Wir haben hier jetzt schon sehr ausführlich sowohl zur Ausbildungsduldung als auch zur Berücksichtigung der Reha-Einrichtungen als Träger der Ausbildung diskutiert oder Stellungnahmen gehört. Mich würde Ihre Position zu beiden Themenkomplexen interessieren.

Dominik Feldmeier (Deutscher Landkreistag): Wir begrüßen, dass die Reha-Einrichtungen ebenfalls Träger der praktischen Pflichtausbildung werden sollen. Wie in meinem Eingangsstatement bereits gesagt, sehen wir es kritisch, dass in den ambulanten Diensten und Krankenhäusern die Pflichteinsätze in ländlichen Räumen teilweise nicht mehr gewährleistet werden können. Daher sehen wir das auch positiv, dass die Reha-Einrichtungen hinzugezogen werden können. Und Ihre erste Frage, könnten Sie diese wiederholen?

Abg. **Sabine Dittmar** (SPD): Die Problematik, die sich derzeit ergibt, ist, dass die 18-monatige Ausbildungsdauer nach dem Aufenthaltsgesetz nicht berücksichtigungsfähig ist. Ob Sie da auch Veränderungen im Aufenthaltsgesetz in der Form befürworten.

Dominik Feldmeier (Deutscher Landkreistag): Wie gesagt, zu der 18-monatigen Ausbildungsdauer sehen wir es eben dahingehend kritisch, dass die Durchlässigkeit nicht ganz gewährleistet werden kann in die generalistische Pflegeausbildung, weshalb wir uns dann überwiegend dafür ausgesprochen haben.

Abg. **Claudia Moll** (SPD): Nochmal eine Frage an Frau Kalberlah. In Ihrer Stellungnahme kritisieren



Sie die vorgesehenen Kenntnisprüfungen und Anpassungslehrgänge nach § 27 als unnötige Doppelstrukturen. Welche Risiken für Bewerberinnen und Schulen sehen Sie, wenn diese Regelung bestehen bleibt?

Isabel Kalberlah (Hans-Weinberger-Akademie der AWO e. V.): Vielen Dank für die Frage. Zum einen ist es wichtig, dass, wenn Kenntnisprüfungen oder Anpassungslehrgänge oder Kenntnisprüfungen mit Vorbereitungskursen in derselben Dauer vorgesehen sind wie die Ausbildung selbst, die Schulen dadurch Doppelstrukturen bewältigen müssten, die bei dem derzeitigen Personalmangel überhaupt nicht mehr leistbar sind. Und zum anderen braucht es dann auch eine gute Theorie-Praxis-Verzahnung. Auf die sollte man auch achten, denn das ist zum Beispiel im Vorbereitungskurs von 320 Stunden auch nicht vorgesehen, dieser soll ja allein auf der theoretischen Basis stattfinden. Und das ist eine Deprofessionalisierung.

Abg. **Sabine Dittmar** (SPD): Mich würde noch interessieren, Frau Owczarek, Sie haben in Ihrer Stellungnahme die Finanzierung der Pflegeschulen beziehungsweise die Pro-Kopf-Finanzierung kritisiert bzw. problematisiert. Jetzt gleicht sich

die Finanzierung letztendlich an die Pflegefachkraft an und auch an die Finanzierungsverordnung. Und damals wurde explizit auf Betreiben des Bundesrates die Maßnahme getroffen, dass sich die Veränderung der Schülerzahl nicht negativ auf die Finanzierung auswirken darf. Jetzt einfach die Frage: Gibt es darüber hinaus weiteren Handlungsbedarf oder ist es ausreichend für Sie?

Katharina Owczarek (Diakonie Deutschland, Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V.): Aus unserer Sicht braucht es vor allem in Bezug auf den Personalschlüssel von 1:20 noch mal eine bessere Kursfinanzierung, die die Vorhaltekosten besser durchführt. Allerdings haben wir da tatsächlich noch keine konkrete Forderung als Diakonie. Deshalb kann ich dazu nichts sagen.

Die **Vorsitzende**: So, ganz herzlichen Dank. Dann sind wir am Ende unserer Anhörung angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen, bei den Sachverständigen, die uns heute Rede und Antwort gestanden haben, auch mit ihren Eingangsstatements. Ich bedanke mich herzlich bei allen Fraktionen für die konstruktiven Fragen und die spannende Debatte und wünsche uns noch einen schönen Tag.

Schluss der Sitzung: 15:32 Uhr

gez. Saskia Esken, MdB
Vorsitzende



Verweise auf Stellungnahmen der Sachverständigen als Anlagenkonvolut:

Isabel Kalberlah Hans-Weinberger-Akademie der AWO e. V. A-Drs. 21(13)9a-neu	Anlage 1
Dr. Elisabeth Fix Deutscher Caritasverband e. V. A-Drs. 21(13)9b	Anlage 2
Dominik Feldmeier Deutscher Landkreistag A-Drs. 21(13)9c	Anlage 3
Melanie Wehrheim Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di A-Drs. 21(13)9d	Anlage 4
Kathrina Edenharter Deutscher Pflegerat e. V. (DPR) A-Drs. 21(13)9e	Anlage 5
Anna Traub Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e. V. A-Drs. 21(13)9f	Anlage 6
Antonia Walch Bundesverband Deutscher Privatkliniken e. V. (BDPK) A-Drs. 21(13)9g-neu	Anlage 7
Katharina Owczarek Diakonie Deutschland Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. A-Drs. 21(13)9h	Anlage 8
Christian Hener Deutsches Rotes Kreuz e. V. A-Drs. 21(13)9i	Anlage 9